TEMA 15 · Comunicación, relación de ayuda y entrevista clínica. Demografía sanitaria e indicadores demográficos

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Comunicación, asertividad, Peplau, relación de ayuda, trabajo en equipo, entrevista clínica y motivacional, escalas de apoyo y sobrecarga · Bloque B: Demografía estática y dinámica, indicadores, índices de envejecimiento, cronicidad y equidad

Siglas y leyes de este tema

Sigla	Nombre completo	De qué va
PAE	Proceso de Atención de Enfermería	Las fases de Peplau se corresponden con él
SBAR / SAER	Situación, Antecedentes (*Background*), Evaluación (*Assessment*), Recomendación	Comunicación estructurada en traspasos
RCP	Reanimación Cardiopulmonar	Situación en la que vale el estilo competitivo
EM / OARS	Entrevista Motivacional / preguntas abiertas (*Open*), Afirmaciones, Reflejos (escucha reflexiva) y Resúmenes (*Summaries*)	Técnica para resolver la ambivalencia
SPIKES	*Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions, Strategy and Summary* (protocolo de Buckman)	Dar malas noticias en 6 pasos
NIC	Clasificación de Intervenciones de Enfermería	La 4920 es la Escucha activa
HADS	*Hospital Anxiety and Depression Scale* (Zigmond y Snaith)	Ansiedad y depresión en pacientes no psiquiátricos (no confundir con HAD, hospitalización a domicilio)
GDS	*Geriatric Depression Scale* (Yesavage)	Depresión en el mayor
INE	Instituto Nacional de Estadística	Censo, padrón (coordina) y movimiento natural de la población
ENSE	Encuesta Nacional de Salud de España	Fuente de datos de salud
ASIS	Análisis de Situación de Salud	Diagnóstico de salud de la comunidad
TSI	Tarjeta Sanitaria Individual	Exige estar empadronado
CV / SM	Crecimiento Vegetativo / Saldo Migratorio	Componentes del crecimiento de la población
EVLI	Esperanza de Vida Libre de Incapacidad	Años que se espera vivir sin discapacidad
GMA	Grupos de Morbilidad Ajustados	Estratificación de crónicos

A1. Fundamentos de la comunicación

- **"Es imposible no comunicar"**. Regla de **Mehrabian** (impacto emocional): **verbal 7%**, **paraverbal 38%** (tono, volumen, ritmo, pausas), **no verbal 55%**. Ante una incongruencia, se cree al mensaje **no verbal**.
- **Kinesia** (gestos, postura, mirada; inclinarse hacia delante = interés), **paralingüística** (silencios terapéuticos) y **proxémica (Edward T. Hall)**:

Distancia	Rango	Uso
Íntima	**0-45 cm**	Procedimientos (higiene, curas): pedir permiso; invadirla sin aviso en pacientes agitados o con demencia provoca agresividad
Personal	**45 cm-1,20 m**	**Entrevista clínica**, valoración, educación individual
Social	1,20-3,60 m	Mostradores, interacciones formales
Pública	> 3,60 m	Charlas y educación grupal

- **Paraverbal**: tono, volumen, ritmo, **entonación**, pausas y silencios, **latencia de respuesta**. La **sonrisa** es **no verbal** (kinesia), no paraverbal.

- **Comunicación terapéutica**: forma parte de la salud, se establece con el paciente, la familia y el entorno, mejora la **alfabetización en salud** y **sí influye en la adherencia** al tratamiento (es falso que no interfiera, SMS 2023).
- **Barreras**: físicas (ruido, interrupciones), psicológicas (prejuicios, negación), **semánticas** (tecnicismos) y fisiológicas (hipoacusia, afasia). Facilitador principal: **escucha activa**.
- **Escucha activa** (NIC 4920 Escucha activa): eliminar distracciones, dominar las propias emociones, no hablar mientras se escucha ("si hablas, no escuchas"); usa **clarificación** (aclarar lo vago) y **resumen** (ordenar ideas y pedir confirmación). Busca **empatía, no simpatía** (es falso que busque una "relación de simpatía", SMS 2022).
- **Técnicas de apoyo narrativo** (ayudan al paciente a contar y elaborar emociones): **facilitaciones** (gestos o frases cortas para que siga), **silencios funcionales**, **clarificaciones**, frases por repetición y empatía. La **alta reactividad** (contestar o interrumpir enseguida) **no** es una de ellas: corta el relato.
- **Obstáculos a la escucha reflexiva (Thomas Gordon)**: ordenar, advertir, aconsejar, moralizar, juzgar, **interpretar**, tranquilizar, interrogar, distraer... También entorpece pedir al paciente que **justifique "por qué"** hace algo.
- Técnicas de comunicación terapéutica (clasificación de los manuales de enfermería): una pregunta abierta y amplia como "¿Qué le preocupa más de la operación de mañana?" se llama **"proporcionar instrucciones generales"** (SMS 2019; no es buscar aclaración ni resumir).
- **Empatía** (SMS 2023): capacidad de **comprender** las preocupaciones cognitivas y emocionales del paciente **y transmitirle** esa comprensión. Se expresa con frases cortas, ajustadas y frecuentes, **con retroalimentación**; **empatía avanzada**: reflejar también lo que el paciente solo ha insinuado.
- **Humor intencional (Leiber)**: valorar el **momento**, la **receptividad** del paciente y el **contenido** (la "creatividad" no es un criterio).
- **Ventana de Johari (Luft e Ingham)**: área **abierta** (conocida por uno y por los demás), **ciega** (los demás la ven, uno no: se reduce con **feedback**), **oculta** (uno la conoce y la esconde: se reduce con **autoexposición**) y desconocida. Objetivo: ampliar el área abierta.

A2. Asertividad

- Estilos: **pasivo** o inhibido (prioriza al otro), **agresivo** (pisa los derechos ajenos) y **asertivo** (defiende los propios derechos respetando los del otro; el **estilo útil para los directivos**, SMS 2019). Las técnicas asertivas sirven frente a la **manipulación emocional**, pero no garantizan que no haya conflicto.

Técnica	En qué consiste
Disco rayado	**Repetir** con calma el mismo mensaje o límite, sin entrar en provocaciones
Banco de niebla (*fogging*)	**Dar la razón en parte** ("es posible que tenga razón…") sin cambiar la postura: no se resiste a la crítica, ni la niega ni contraataca
Aserción negativa	Reconocer un error real de forma breve, sin autohumillarse
Interrogación negativa	Pedir detalles ante una crítica genérica ("¿qué te molesta exactamente?")
Asertividad empática	Validar primero el sentimiento del otro y después marcar el límite
Mensajes yo (Thomas Gordon)	Describir la conducta objetiva → expresar el sentimiento → consecuencia → propuesta de cambio (frente al acusatorio "mensaje tú")

A3. Hildegard Peplau (1952): relaciones interpersonales

Fase	Contenido	Equivale en el PAE
Orientación	El paciente busca ayuda; se clarifica el problema y se crea confianza	Valoración y diagnóstico
Identificación	El paciente se identifica con quien le ayuda; se fijan metas	Planificación
Explotación (aprovechamiento)	Saca el máximo partido a los servicios; asume control	Ejecución
Resolución	Necesidades satisfechas; se disuelve la relación y se logra independencia	Evaluación y alta

- **6 roles**: extraño, persona recurso, docente, líder, sustituto (transferencia) y **consejero**, el **de mayor importancia** según Peplau. Peplau, "madre de la enfermería psiquiátrica".

A4. Relación de ayuda

- Intervención deliberada y temporal para que la persona **movilice sus propios recursos**; no es compadecer ni dar consejos paternalistas. No es "una conversación", "una charla" ni "una relación social" (SMS 2019).
- **Counselling** (consejo asistido): proceso interactivo de comunicación que ayuda a la persona a **reflexionar y tomar sus propias decisiones** según sus valores, intereses y estado emocional.
- **Carl Rogers** (terapia centrada en el cliente): **aceptación positiva incondicional**, **empatía** (comprender "como si" fuera propio, sin perder el "como si") y **congruencia o autenticidad**. La **simpatía** (contagio emocional) es antiterapéutica y favorece el burnout.
- **Robert Carkhuff** (modelo de destrezas, entrenable): fases de **exploración** → **comprensión** → **acción**. Respuestas no facilitadoras: **detective** (interroga), **juez** (evalúa y moraliza), **sargento** (ordena), **florista** (falso consuelo: "todo saldrá bien"), mago (adivina) y etiquetador.
- **Chalifour**: relación de ayuda integrada en todo el PAE; **cuidados invisibles**. **Escuela española (Luis Cibanal y Diego José Ibáñez, Alicante)**: la comunicación **tiene valor terapéutico** ("la comunicación ayuda a curar"), enfoque sistémico (paciente y familia).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Ante un paciente que llora, la respuesta correcta es **estar presente, escuchar y acompañar**, nunca "no se preocupe, todo saldrá bien" (florista).

A5. Trabajo en equipo

- **Grupo** (tareas independientes) frente a **equipo** (objetivo común, interdependencia, responsabilidad compartida).
- **Multidisciplinar** (disciplinas en paralelo, comunicación escrita), **interdisciplinar** (plan único y objetivos compartidos, sesiones conjuntas; aspiración de la AP) y **transdisciplinar** (fronteras difuminadas, el paciente forma parte del equipo, ***role release***).

Tuckman (1965; 1977)	
Formación (*forming*)	Cortesía, incertidumbre, dependencia del líder
Conflicto (*storming*)	Luchas de poder; fase dolorosa pero necesaria
Normalización (*norming*)	Cohesión, roles y normas
Desempeño (*performing*)	Máximo rendimiento y autonomía
Disolución (*adjourning*, 1977)	Fin del equipo, duelo

- **SBAR / SAER** (traspasos y llamadas): **Situación**, **Antecedentes**, **Evaluación** (incluye el **juicio clínico** de la enfermera, no solo las constantes) y **Recomendación** (propuesta concreta de acción).
- **Thomas-Kilmann** (asertividad × cooperación): **competitivo** (gano/pierdes; **útil en una RCP**), acomodaticio, evitativo, compromiso (partir la diferencia) y **colaborativo** (gano/ganas; el ideal en el día a día).

A6. Entrevista clínica (Borrell) y entrevista motivacional

- Entrevista clínica: encuentro estructurado con propósito (inicio, desarrollo, cierre), roles asimétricos y secreto profesional.
- **Borrell**: fase **exploratoria** (recabar información) y fase **resolutiva** (informar, proponer y **negociar**). Habilidades **instrumentales** (el "qué": tipos de preguntas, resúmenes) e **interaccionales** (el "cómo": calidez, empatía, silencios).
- **Preguntas**: para obtener la mayor información, **combinar abiertas y cerradas** (SMS 2022): abiertas al principio, cerradas para concretar.

- Técnicas: saludo cordial (**marcador de clima**), preguntas abiertas, **vaciado de la información preelaborada** (dejar hablar sin interrumpir al inicio) y prevención del **síndrome del picaporte** ("¿hay algo más que le preocupe hoy?"). Si aparece al final, valorar la gravedad: si es urgente, se atiende.
- **Entrevista motivacional (Miller y Rollnick, 1991)**: estilo de conversación **colaborativo** para reforzar la motivación y el compromiso con el cambio; su estilo es **de guía** (entre el directivo y el de acompañamiento; verbos como **asistir**, orientar, animar). La **ambivalencia es normal** en el camino al cambio (no anormal); si el profesional defiende el cambio de forma directiva, el paciente defenderá lo contrario. La motivación es un estado modificable. Fase diana: **contemplación**. La **recaída** forma parte del ciclo (sin culpabilizar).
- **Malas noticias** (no solo en cáncer terminal): **protocolo SPIKES de Buckman**, 6 pasos: **1** preparar el entorno (*Setting*), **2 averiguar cuánto sabe el paciente** (*Perception*), **3** averiguar cuánto quiere saber (*Invitation*), **4** dar la información (*Knowledge*), **5** responder a las emociones (*Emotions*, empatía) y **6** plan y resumen (*Strategy and Summary*).
- **Sospecha de maltrato**: entrevistar **a solas**, **abordar directamente** el tema de la violencia, permitir los silencios; nunca terapia de pareja. Si lo niega: **escucha activa y apoyo** a sus decisiones.
- **4 principios**: expresar **empatía**, **desarrollar la discrepancia** (conducta frente a valores), **rodar con la resistencia** (no confrontar) y **apoyar la autoeficacia**. Técnicas **OARS**: preguntas abiertas, afirmaciones, **escucha reflexiva** (núcleo de la técnica) y resúmenes.

A7. Escalas de valoración del apoyo emocional y social

Escala	Mide	Puntuación y cortes
Zarit (22 ítems)	**Sobrecarga del cuidador**	Versión española (1-5 por ítem): **< 47 sin sobrecarga**, **47-55 leve**, **> 55 intensa**. **Abreviada de 7 ítems: ≥ 17** = sobrecarga
Duke-UNC-11	**Apoyo social funcional percibido** (subjetivo)	11 ítems (11-55); dimensiones **confidencial** y **afectiva**; **a menor puntuación, menor apoyo** (≤ 32 apoyo escaso, según el manual)
Apgar familiar (Smilkstein, 1978)	Funcionalidad familiar percibida	5 ítems (0-2): Adaptabilidad, Participación, Crecimiento (*Growth*), Afecto, Resolución. **7-10 normofuncional**, **4-6 disfunción leve**, **0-3 grave**
HADS (Zigmond y Snaith)	**Ansiedad y depresión en pacientes no psiquiátricos**	14 ítems (7 + 7); **excluye síntomas somáticos**; cada subescala **0-7 normal, 8-10 dudoso, ≥ 11 caso**
Escala de Gijón	Situación **sociofamiliar** del mayor	5 áreas (5-25): **5-9 normal**, **10-14 riesgo social**, **≥ 15 problema social**
Yesavage (GDS-15)	Depresión geriátrica	Sí/No; **0-4 normal**, 5-9 depresión leve, ≥ 10 establecida

BLOQUE B · Demografía sanitaria

B1. Conceptos, transiciones y demografía estática

- La demografía aporta el **denominador** de las tasas y es la base del **Análisis de Situación de Salud (ASIS)** y de la asignación de cupos (TSI): sirve para **planificar en salud pública, calcular tasas e indicadores y hacer estudios epidemiológicos** (SMS 2019: "todas son correctas").
- **Transición demográfica (Notestein, 1945)**: de alta natalidad y mortalidad a baja natalidad y mortalidad. **Transición epidemiológica (Omran, 1971)**: de enfermedades infecciosas a **crónicas** y degenerativas.
- **Demografía estática** ("fotografía"): dimensión, territorio y estructura (edad y sexo).

	Censo	**Padrón**
Responsable	**INE**	**Ayuntamientos** (coordina el INE)
Periodicidad	Decenal (años terminados en 1)	**Continua**
Carácter	Estadístico, **secreto estadístico**	Administrativo y **público**; prueba de residencia; necesario para la **TSI**

- **Población de hecho** = residentes presentes + **transeúntes**. **Población de derecho** = residentes presentes + **residentes ausentes**.
- Encuestas: **ENSE** (Ministerio de Sanidad e INE) y **Encuesta Europea de Salud** (cada 5 años, Eurostat).
- **Pirámide**: edades en el eje vertical, hombres a la **izquierda** y mujeres a la derecha. Pagoda o expansiva (joven), campana o estacionaria y **bulbo, urna o regresiva** (España y Murcia; el "abultamiento" de **50-70 años** es el ***baby boom***, que llegará a los 65 en la próxima década).

B2. Demografía dinámica

- Fuentes: **Registro Civil → Movimiento Natural de la Población (INE)**.
- **Ecuación compensadora**: P1 = P0 + N − D + I − E. **Crecimiento vegetativo = N − D** (negativo en España y Murcia). **Saldo migratorio = I − E**. **Crecimiento real = CV + SM**: puede ser positivo con CV negativo si la inmigración lo compensa.
- **Proporción** (el numerador está en el denominador), **razón** (no lo está: razón de masculinidad) y **tasa** (incluye el tiempo).

Indicador	Cálculo
Tasa bruta de natalidad	Nacidos vivos en un año / **población total media** de ese año × 1.000
Tasa de fecundidad general	Nacidos vivos / **mujeres de 15-49 años** × 1.000
Índice sintético de fecundidad	Hijos por mujer; **reemplazo: 2,1** (España ≈ 1,1-1,2)
Tasa bruta de mortalidad	Defunciones / población media × 1.000 (alta en países envejecidos)
Mortalidad específica	Denominador: **solo el subgrupo** (p. ej., varones de 40-44 años)
Mortalidad infantil	Muertes < 1 año / **nacidos vivos** × 1.000
Mortalidad materna	Muertes por embarazo, parto o puerperio / **nacidos vivos** × **100.000**

- **Tasa de mortalidad neonatal**: muertes de nacidos vivos **antes de los 28 días** en un año / nacidos vivos de ese año × 1.000.
- **Neonatal**: < 28 días (**precoz < 7 días**, causas endógenas y obstétricas; tardía 7-27 días). **Postneonatal**: 28 días a < 1 año (causas **exógenas**: infecciones, accidentes; la más sensible a la enfermería comunitaria).
- **Mortalidad perinatal**: en España (**INE**) muertes fetales desde las **28 semanas** + muertes en los **primeros 7 días**; la OMS la inicia en las **22 semanas** (o ≥ 500 g); la "ampliada" llega hasta los 28 días.
- **Incidencia**: la **acumulada** es una **proporción sin unidades** y, aplicada a una persona, es su **riesgo**; si todos han estado expuestos **el mismo tiempo**, se usa la **incidencia acumulada** (la **densidad de incidencia** es para tiempos de seguimiento distintos). En poblaciones **dinámicas**, el denominador es la **población a mitad del periodo**.
- **Esperanza de vida al nacer**: indicador **transversal e hipotético** (tasas del año), no una predicción. **EVLI** (libre de incapacidad): a los 65 años es ligeramente mayor en varones en España (0,1 años).

B3. Índices de estructura

Índice	Fórmula	Interpretación
Envejecimiento	Mayores / jóvenes × 100	> 100 = más mayores que jóvenes. Murcia superó el 100% en 2025 (102,7%); España ≈ 148% (según el manual)
Dependencia global	(< 15 + ≥ 65) / **15-64** × 100	Denominador **siempre la población activa**; España ≈ 53
Dependencia senil	≥ 65 / 15-64 × 100	
Generacional de ancianidad	**35-64 / ≥ 65** × 100	Si baja, **menos cuidadores potenciales**
Sundbärg	< 15 frente a ≥ 50 (base 15-49)	Vieja si ≥ 50 > < 15

Índice	Fórmula	Interpretación
Fritz (en el examen SMS, "Friz")	0-19 / 30-49 × 100	> 160 joven; 60-160 madura; **< 60 vieja**
Burgdöfer	5-14 frente a 45-64	**Vieja si 5-14 < 45-64**

B4. Envejecimiento, cronicidad y equidad

- **Fries**: **compresión de la morbilidad** (concentrar la discapacidad al final de la vida) frente a expansión (más años con enfermedad).
- **Paciente pluripatológico**: ≥ 2 enfermedades crónicas, inestabilidad, síndromes geriátricos, polifarmacia, "puerta giratoria".
- **Longitudinalidad**: el mismo profesional a lo largo de la vida. **Continuidad asistencial**: coordinación entre niveles (AP, hospital, sociosanitario).

Pirámide de Kaiser Permanente	Población	Intervención
Nivel 1 (base)	70-80%	Promoción y prevención, autocuidado
Nivel 2	15-20% (crónicos de baja complejidad)	**Gestión de la enfermedad** (*disease management*), EpS grupal
Nivel 3 (cúspide)	**3-5%** (crónico complejo; > 50% de los recursos)	**Gestión de casos** (*case management*): **enfermera gestora de casos**

- Enfermera gestora de casos: captación proactiva (listados de estratificación GMA), valoración geriátrica integral, enlace de recursos, alta compleja y atención al cuidador (Zarit).
- **Igualdad** (lo mismo para todos) frente a **equidad** (a cada cual según su necesidad). **Desigualdad**: cualquier diferencia medible (puede ser biológica). **Inequidad**: desigualdad **sistemática, evitable e injusta**.
- **Curva de Lorenz** y **coeficiente de Gini**: **0 = igualdad perfecta**, **1 = desigualdad máxima**.
- **Dahlgren y Whitehead** (numerados de dentro afuera, como en el EIR; ver tema 14): **1** núcleo (edad, sexo, genética), **2** estilos de vida, **3 redes sociales y comunitarias** (familia, soledad), **4** condiciones de vida y trabajo (incluido el sistema sanitario) y **5** condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Disco rayado = **repetir**; banco de niebla = **dar parte de razón** sin ceder.

! **Población de derecho = presentes + ausentes; de hecho = presentes + transeúntes.**

! **Mortalidad infantil y materna: denominador nacidos vivos (la materna, × 100.000).**

! Las tasas de dependencia tienen como denominador la población de **15-64 años**.

Otras preguntas del test de este tema

- **Margaret Sanger**: enfermera estadounidense pionera del **control de la natalidad** y de la legalización de los anticonceptivos.
- **Pensamiento crítico enfermero**: los prejuicios sesgan el juicio, la prisa y las interrupciones lo empeoran y conocer el **patrón típico de respuesta del paciente sí es relevante**.
- **Puntuación de cambio de un NOC** = puntuación final − basal: si empieza en 1 y acaba en 1, el cambio es **0** (aunque la diana fuera 4).
- **Ajzen**: su teoría (conducta planificada) es una teoría **individual** del comportamiento en salud.
- **Memoria (Atkinson y Shiffrin, 1968)**: el almacén **a corto plazo** funciona como **memoria de trabajo**; recibe información del registro sensorial y del almacén a largo plazo.
- **Inteligencia emocional**: reconocer y manejar las emociones propias y ajenas. **Salovey y Mayer**: 4 ramas, **percepción, facilitación, comprensión y regulación** (no "desarrollo emocional").
- **Aprendizaje experiencial de Kolb**: **experiencia concreta → observación reflexiva → conceptualización abstracta → experimentación activa**.

- **Violencia vicaria**: violencia intrafamiliar que daña a otra persona (normalmente los hijos) para hacer daño a la mujer, que es el objetivo real.
- **Aislamiento social** (Comisión de la OMS sobre Conexión Social, 2025): lo vive en torno al **25-34 % de los mayores de 60 años**.
- **Violencia sexual** (Protocolo del SNS 2023): entre sus consecuencias, **trastornos gastrointestinales** (dolor abdominal, colon irritable); aumenta el uso de servicios y la mortalidad materna y perinatal. Es la forma menos reconocida socialmente como tal: **pagar por sexo** (prostitución).
- **Síndrome de Yentl**: investigación centrada en varones que invisibiliza a las mujeres (infradiagnóstico e infratratamiento).
- La **gestación por subrogación** es una vulneración grave de los derechos reproductivos y una forma de violencia contra las mujeres (ley española, en línea con el Convenio de Estambul de 2011).
- **Heterosexismo**: considerar la heterosexualidad la única orientación válida. **Brecha de género vertical**: pocas mujeres en puestos de dirección.
- **Mujeres mayores** víctimas de violencia de género: son las que **más tardan en decidir denunciar**.
- **Chinches de cama**: la reacción puede tardar días y la latencia **disminuye** con nuevas picaduras; pican en zonas expuestas y no se ha demostrado que transmitan infecciones.
- **Oxiuros**: tratar a **toda la familia a la vez**. **Garrapata**: pinzas romas lo más cerca de la piel, **tracción lenta y constante** y después desinfectar (nada de alcohol ni vaselina para que se suelte).
- **Sustancias pirogénicas**: estimulan las células inmunitarias y **producen una respuesta inflamatoria** (fiebre); las endotoxinas son un tipo, no un sinónimo.
- **Cobertura vacunal**: vacunados / **población objetivo**. **Cobertura crítica**: porcentaje de inmunes necesario para que el número de transmisión sea **menor de 1**.
- **Sarampión en sanitarios**: inmunes sin serología si tienen **2 dosis documentadas** de triple vírica o la enfermedad pasada.
- **Calendario 2020**: los vacunados a los 2, 4 y 11 meses reciben DTPa/VPI a los **6 años** (no a los 4); VPH a las niñas a los 12 años (2 dosis); varicela en adolescentes no inmunes (2 dosis); neumococo a partir de los 65.
- **Gripe, grupos diana**: implante coclear (niños desde 6 meses y adultos), embarazadas **en cualquier trimestre**.
- **No existe relación** entre la triple vírica y el autismo.
- **Td en adultos**: si la primovacunación está incompleta, **no se reinicia**: se completa hasta 5 dosis; vacunados correctamente en la infancia, un recuerdo hacia los 65 años; herida tetanígena con 5 dosis y la última hace 8 años: no hace falta vacuna.